

고혈압 약, 미루지 말아야 하는 이유

혈압약은 **혈압 자체**가 아닌 **혈압이 만드는 합병증(뇌·심장·신장·눈·대혈관)**을 막기 위해 먹습니다. 운동·식이·체중관리는 약과 **함께 가는 동반자**이며, 안정되면 감량·중단할 수 있습니다.

왜 지금 시작해야 하나요? (Key Numbers)

미치료 5년 시 뇌졸중 위험

2~3

배 ↑ (정상혈압 대비)

약 + 생활관리 병행 시 심혈관 사건

40

% ↓ (SPRINT · HOPE-3)

혈압 안정 후 약 감량·중단 가능

15~20

% (생활관리 정착 시)

혈압을 방치하면 — 무증상으로 진행되는 5대 합병증 (Silent Damage)

2

고혈압성 망막병증

눈 모세혈관 손상 → 시야 흐림·출혈·실명.
본인은 못 느끼고 안저검사서만 발견.

4

대동맥 박리·동맥류

혈관 벽이 찢어지는 **생명 응급**. 갑작스러운 찢어지는 흉통·등 통증.

1

뇌졸중 · 혈관성 치매

어느 날 갑자기 **마비·언어장애·의식소실**.
고혈압은 뇌졸중 최대 위험인자 (3~5배).

3

심근경색 · 심부전

관상동맥 동맥경화 가속 → **흉통·돌연사·호흡곤란**. 좌심실 비대로 심장이 굳어짐.

5

만성신부전 · 투석

사구체 손상 → 단백뇨·신기능 저하 → **투석·이식**. 당뇨와 함께 양대 원인.

흔한 오해 vs 올바른 접근 (Common Myths)

자주 듣는 오해 · MYTH

- "지금 증상 없으니 괜찮다" — 합병증은 무증상으로 진행
- "운동·영양제로 잡을 수 있다" — 140/90 이상은 단독 효과 미흡
- "약 시작하면 평생 먹어야 한다" — 안정되면 감량·중단 가능
- "약이 신장·간에 부담을 준다" — 오히려 신장 보호, 미치료가 더 위험

근거 있는 접근 · FACT

- 진단 즉시 **약 + 생활관리 동시 시작** — 따로가 아닌 같이
- 가정혈압 매일 측정** — 아침·자기 전 (진료실보다 정확)
- 저염식 + 유산소 30분 + 체중 5kg 감량** — 약 효과 ↑ + 감량 가능성 ↑
- 3개월마다 정기 진료** — 약 조정 + 합병증 조기 발견

약을 끊을 수 있나요? — 감량·중단 로드맵 (Tapering Roadmap)

STEP 1 · 0~3개월

약 + 생활관리 동시 시작

약물로 즉시 혈압 안정. 가정혈압 측정·식이·운동 습관화. 이 시기에 약을 미루면 합병증 위험이 누적됩니다.

STEP 2 · 3~12개월

혈압 안정 + 생활습관 정착 확인

가정혈압이 6개월 이상 **130/80 이하** 안정 + 체중·식이·운동이 정착되면 **의사와 상의해 약 용량 감량**을 검토합니다.

STEP 3 · 1년 이상

단계적 중단 + 정기 모니터링

감량 후에도 혈압이 안정적이면 **단계적 중단** 가능. 단, **가정혈압·연 1회 검진**은 평생 유지 — 재상승 시 즉시 재개합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: 2022 대한고혈압학회 (KSH) · 2023 ESH · 2024 AHA/ACC Hypertension Guideline · SPRINT (NEJM 2015) · HOPE-3 (NEJM 2016). 본 자료는 일반 안내이며 개인의 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → gwanggyo-barun.github.io/patient-education/handouts/medication/htn-why-start/